

肤癌及脑肿瘤等多种肿瘤。

(1) 治食管癌 威灵仙 50g, 醋、蜜各半碗, 水煎服, 每日 1 剂。亦可用于胃癌、肠癌。若与猫眼草、制南星、急性子、郁金、山甲等伍用, 则可加强抗癌作用。

(2) 治脑肿瘤 威灵仙、蚤休各 30g, 木瓜 9g, 水煎服, 同时吞服三七粉 3g, 每日 1 剂。

7 治疗流行性腮腺炎

取鲜威灵仙根洗净, 切细, 捣烂。每用 500g 加米醋 250ml, 浸于玻璃瓶内, 盖紧勿令泄气。3 日后取出醋浸液, 用棉签蘸涂患处, 每 2~3 小时涂擦 1 次。一般于药后 1~3 日即愈。

8 治疗颈淋巴结结核

取鲜威灵仙根适量, 洗净, 捣烂呈糊状。取 30mm×30mm 的胶布, 将其中中央剪一直径约 15mm 大小的圆孔, 置于内关穴位(男敷左, 女敷右)或颈淋巴结结核患处, 在孔中放适量捣烂的威灵仙后再盖上一层胶布, 固定 24 小时后即将药渣取出。敷处可见起一水泡, 用生理盐水将局部清洗干净, 再用消毒针头将水泡挑破, 抽出或溢出泡内液体, 涂以龙胆紫或消炎药膏, 用消毒敷

料包扎即可。谢正强报道用该法治疗 200 余例, 其中观察随访 50 例, 结果: 治愈(症状消失, 结节消散或溃疡愈合, 观察 2 年未复发, 局部皮肤仅留色素沉着)47 例, 好转(症状减轻, 结节明显缩小或消失, 但 2 年内复发)3 例。

目前未见威灵仙有抗结核杆菌的报道, 但验之临床确实有效, 推测其机制可能为抑制结核菌繁殖, 以及与发泡作用刺激和调动人体自身抗结核能力有关。

9 治疗急性乳腺炎

急性乳腺炎多与乳汁郁滞、乳络不通有关。威灵仙辛散温通, 又有抗病原微生物作用。取鲜威灵仙根适量, 洗净, 捣烂, 加米醋拌成糊状, 30 分钟后贴敷于乳腺炎患处, 随干随换, 一般 1~3 日即愈。

10 治疗痔疮肿痛

用威灵仙、防风各 60g, 水煎, 熏洗。

11 治疗牛皮癣

用威灵仙 30g, 水煎, 早晚各服 1 次。疗程不限, 至癣屑脱尽为止。

(2000-05-17 收稿)

[马莉萍 编发]

• 不合理处方分析 •

环孢菌素 A 的药物相互作用(二)

王少华 陈安进

266011 青岛市市立医院临床药理基地

处方 4 山地明与卡马西平

卡马西平 200mg×20 100mg tid po
山地明 50mg×50 150mg bid po

(视病情调整剂量)

处方分析:卡马西平能通过细胞色素 P-450 系统增加肝脏对环孢素的代谢。因此当两药合用时, 环孢素体内消除增加, 血清浓度下降。在停用卡马西平后, 此作用仍可能持续 1 周或更长时间。另据报道, 环孢素与苯妥英钠、苯巴比妥等联合应用时也有此相互作用。

处理方法:两药联合应用时, 应密切监测环孢素的浓度, 相应增加环孢素用量以维持其有效血药浓度。或用丙戊酸替代卡马西平, 丙戊酸不影响 CsA 的浓度, 但可能损伤移植肾。

处方 5 山地明与地尔硫革

盐酸地尔硫革缓释片 30mg×36 30mg tid po

山地明 50mg×50 150mg bid po

(视病情调整剂量)

处方分析:地尔硫革与环孢素合用, 可使环孢素血药浓度升高, 有研究表明两药合用虽增加了环孢素的血药浓度, 但其肾毒性较低。其他钙通道阻滞剂如维拉帕米和尼卡地平均可升高环孢素的血药浓度, 且具有保护肾组织、增加免疫抑制和改善肾移植存活率的作用。硝苯地平与环孢素合用, 使硝苯地平的不良反应(潮红和药疹)增加, 但不影响环孢素的血药浓度。

处理方法:地尔硫革与环孢素的相互作用虽已被公认, 但此作用对患者无害, 且地尔硫革还具有肾保护作用, 因此无须避免两药合用, 但应密切监测环孢素的血药浓度, 必要时降低环孢素的剂量。

处方 6 山地明与酮康唑

山地明 50mg×50 150mg bid po

(视病情调整剂量)

•运动处方•

冠 心 病 的 运 动 处 方

齐 雨 青

100020 首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心

心脏事件(心肌梗死、心力衰竭和冠脉搭桥术等)发生后,左心室功能受损或长时间的卧床导致机体不适应,表现为交感神经活性增加,迷走神经活性降低,直立及平卧状态下心动过速以及对运动的反应性心率增加不良。运动能①增加骨骼肌血液灌注和摄氧能力,改善心脏收缩功能;②改善心肌氧合作用,改善运动和静息状态下的低血压及心率增快,因而增加运动耐力和强度。因此,早期活动及缩短住院时间是减轻以上不良变化的有益措施。

1 住院期的运动计划

1.1 在冠心监护室,心脏事件发生后的前 24~48 小时,大多数患者可进行被动性运动,病情稳定应尽早开始自主性活动如洗脸、刷牙等。

1.2 转入普通病房后,尽可能保持头直立位,在帮助下行走。

频率:1 天 2 次。

强度:以 Borg 得分(见表 1)和心率决定活动的强度和时间,要求患者活动后的心率增加不大于 20 次/分,Borg 得分不大于 14。

表 1 Borg 用力计分表

非常、非常轻	6
	7
非常轻	8
	9
轻	10
	11
有些费力	12
	13
费力	14
	15
非常费力	16
	17
非常、非常费力	18
	19
	20

运动时间:大多数患者第 1 天可坚持 5 分钟,以后逐渐增加运动时间,最终达 30 分。

内容:行走、爬楼梯等。

2 出院后的运动计划

2.1 心脏事件发生后,若无并发症,心肌梗死后 7~21 天、冠脉内球囊扩张术后 3~10 天、心脏手术后 14~28 天后即可行次极量运动试验,出院后 6~8 周可进行极量运动试验,采用改良的 Naughton 方案。

2.2 运动训练开始后,需每 4~8 周做一次运动试验,指导运动训练。运动计划以运动试验结果为基础,持续 8~12 周。

频率:每周运动 3 次。

运动时间:每次持续 30~60 分钟。

强度:开始采用运动试验所取得最大心率的 65%,以 Borg 计分为尺度,衡量运动强度,以 13~14 分为适度,随着对运动量的适应,Borg 计分下降,此时运动量可增加,每次增加最大心率的 5%~15%,最终达最大心率的 85%。

内容:每次运动训练包括三个阶段:10 分钟预备活动、40 分钟有氧运动(散步、小跑及踏车等)及 10 分钟的放松运动。

3 注意事项

3.1 不稳定血流动力学障碍、不稳定心肌缺血及未控制的心律失常的患者不适应运动训练。

3.2 运动能诱发心力衰竭和心肌缺血的患者运动最大心率应低于诱发病状心率至少 10 次/分,此类患者运动训练应在监测下进行。

3.3 运动训练对心律失常的影响尚不明确,运动可诱发室性心律失常的高危患者不适应运动训练。

(2000-09-14 收稿 2000-10-15 修回)

[陈 磊 编发]

酮康唑 200mg×20 400mg qd po

处方分析:两药合用使血清环孢素浓度明显升高,有增加肾毒性的危险,可能是因为酮康唑改变了体内分布容积或某些蛋白结合点改变所致.cnki.net

处理方法:避免合用。如确须合用,应减少环孢素的给药剂量,同时监测血清环孢素浓度和肾功能。

(未完待续)

(2000-09-18 收稿) [于小雪 编发]